

LISTE DES ABREVIATIONS

BCG	: Bacille de Calmette et Guérin
CCSC	: Communication pour le Changement Social du Comportement
CHS	: Centre Hospitalier Spécialisé
CMU	: Couverture Maladie Universelle
DCPEV	: Direction de la Coordination du Programme Elargi de Vaccination
DEPEV	: Direction Exécutive du Programme Elargi de Vaccination
DN-HepB	: Dose Naissance de L'Hépatite de Type B
EPHN	: Etablissement Public Hospitalier National
EPHD	: Etablissement Public Hospitalier Départemental
EPHR	: Etablissement Public Hospitalier Régional
ESPC	: Etablissement Sanitaire de Premier Contact
FAR	: Femme en Âge de Reproduction
HPV 1	: Human Papilloma Virus 1ère dose
HPV 2	: Human Papilloma Virus 2ème dose
HPV 3	: Human Papilloma Virus 3ème dose
HTA	: Hypertension Artérielle
IDE	: Infirmier Diplômé d'Etat
M	: Maïeuticien
Men A	: Méningite de type A
MSHP-	: Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture
CMU	Maladie Universelle
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
PEV	: Programme Elargi de Vaccination
RDV	: Rendez-vous
RR1	: Rougeole/Rubéole 1ère dose
RR2	: Rougeole/Rubéole 1ère dose
SF	: Sage-Femme

SIDA	: Syndrome Immuno- déficience Acquise
SR/PF	: Santé de la Reproduction/ Planification familiale
TB	: Tuberculose
Td 1	: Tétanos Diphtérie 1 ^{ère} dose
Td 2	: Tétanos Diphtérie 2 ^{ème} dose
Td 3	: Tétanos Diphtérie 3 ^{ème} dose
Td 4	: Tétanos Diphtérie 4 ^{ème} dose
Td 5	: Tétanos Diphtérie 5 ^{ème} dose
UNICEF	: Fonds des Nations Unis pour l'Enfance
VAA	: Vaccin Anti Amaril
VAP 1	: Vaccin Contre le Paludisme 1 ^{ère} dose
VAP 2	: Vaccin Contre le Paludisme 2 ^{ème} dose
VAP 3	: Vaccin Contre le Paludisme 3 ^{ème} dose
VAP 4	: Vaccin Contre le Paludisme 4 ^{ème} dose
VIH	: Virus Immunodéficience Humaine
VPI 1	: Vaccin Polio Inactivé 1 ^{ère} dose
VPI 2	: Vaccin Polio Inactivé 2 ^{ème} dose
VPO 0	: Vaccin polio Orale 1 ^{ère} dose
VPO 1	: Vaccin polio Orale 2 ^{ème} dose
VPO 2 dose	: Vaccin polio Orale 3 ^{ème}
VPO 3	: Vaccin polio Orale 4 ^{ème} dose

Objectif général.

Ce cours vise à permettre à l'étudiant (e) infirmier (ère), Sage-femme et Maïeuticien de la L1 de comprendre le concept de santé publique.

Objectifs spécifiques.

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Définir le concept de santé Publique
- 2) Définir les notions liées à la santé publique
- 3) Etablir la différence entre la santé publique et la santé communautaire
- 4) Enoncer les grands courants qui ont façonné l'histoire de la santé publique
- 5) Décrire l'évolution du concept de santé publique.
- 6) Identifier les événements ayant marqué l'histoire de la santé publique
- 7) Citer les étapes de la démarche en santé publique
- 8) Appréhender les niveaux de perception des problèmes de santé publique
- 9) Citer les facteurs pouvant influencer la mise en œuvre d'une politique de sante publique

I- DEFINITIONS DU CONCEPT DE SANTE PUBLIQUE

Avant de définir le concept, définissons d'abord les mots qui le composent.

✓ Santé.

La santé est un « état de complet bien-être physique, mental et social et (qui) ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». [OMS, 1946].

✓ Publique

Selon le dictionnaire LAROUSSE, le mot désigne ce qui est ouvert à tous, au public dans son ensemble (Larousse, 2019)

✓ Santé Publique

▪ Définition selon Abraham Winslow

La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficacité physique à travers les efforts coordonnés de la communauté pour l'assainissement de l'environnement, le contrôle des infections dans la population, l'éducation de l'individu aux principes de l'hygiène personnelle, l'organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des pathologies, le développement des dispositifs sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le maintien de la santé. (Winslow, 1920)

▪ Définition selon l'Organisation Mondiale de la Santé

La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentales et physiques des individus, par le moyen d'une action collective concertée visant à assainir le milieu, lutter contre les maladies, enseigner les règles d'hygiène personnelle, organiser des services médicaux et infirmiers en vue d'un diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies, mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. (OMS, 1952)

II. DEFINITIONS DES NOTIONS LIES A LA SANTE PUBLIQUE

✓ Communauté

C'est un groupe d'individus qui vivent ensemble dans des conditions spécifiques d'organisation et de cohésion sociales. Ses membres sont liés à des degrés variables par des caractéristiques politiques, économiques, sociales et culturelles communes ainsi que par des intérêts et des aspirations communs, y compris en matière de santé. (OMS, UNICEF, 1978).

✓ Santé communautaire

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), la santé communautaire ou démarche communautaire en santé est le processus par lequel les membres d'une collectivité, géographique ou sociale, conscients de leur appartenance à un même groupe, réfléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les plus aptes à répondre à ces priorités.

✓ Agent de santé communautaire

Selon l'Organisation International du Travail (O.I.T.), un agent de santé communautaire (A.S.C) est une personne ayant une formation diplômante qui fait de l'éducation sanitaire, de la référence, le suivi, la gestion des cas, les soins de santé préventifs de base et les services de visites à domicile à des communautés spécifiques.

En Côte d'Ivoire c'est un bénévole qui travaille à temps partiel et qui réside dans les collectivités, assure l'éducation sanitaire, la référence, la prévention et la prise en charge des cas simples, le suivi ainsi que les visites à domicile dans des communautés déterminées.

✓ Soins de santé primaires

La conférence internationale sur les soins de santé primaires (SSP) de 1978 définit les SSP comme des « soins essentiels, fondés sur des méthodes et une technologie pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus universellement accessibles aux individus et aux familles dans la communauté, par leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à chaque stade de leur développement, dans un esprit d'auto responsabilité et d'autodétermination.

Ils font partie intégrante du système de santé dont ils sont la cheville ouvrière ainsi que du développement économique et social de la communauté. »

✓ Système de santé (système de soins)

Un système de santé se définit comme la totalité des organisations, institutions et ressources consacrées à la production d'actions visant principalement à améliorer, maintenir ou restaurer la Santé (OMS, 2022).

✓ Politique de santé publique

La politique de santé publique est un ensemble d'orientations, de choix stratégiques et de décisions prises par les pouvoirs d'un pays pour maintenir et/ou améliorer l'état de santé d'une population.

✓ Action de santé publique

C'est une opération collective en vue de l'amélioration de la santé d'une population.

✓ Programme de santé

C'est un ensemble coordonné d'actions ou stratégies misent en œuvre pour atteindre un objectif.

✓ Promotion de la santé

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), la promotion de la santé est le processus qui consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et d'améliorer ainsi leur santé. La participation de la population est essentielle dans toute action de promotion de la santé.

✓ Prévention

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), la prévention est une stratégie qui consiste à améliorer le niveau de santé par une diminution de la mortalité, de la morbidité et des facteurs de risque ou une augmentation de la résistance des individus face aux agents agresseurs. Il existe quatre types de prévention.

1.2.1 La prévention primaire

Elle consiste à lutter contre les risques avant l'apparition de tout problème de santé. (Exemple : la vaccination).

2.2.2 Prévention secondaire

Elle consiste à dépister une maladie afin d'instituer le traitement précoce pour éviter les complications. (Exemple : dépistage du cancer du col de l'utérus).

2.2.3 Prévention tertiaire

Elle vise à prévenir les rechutes ou les complications par la rééducation et l'éducation thérapeutique du patient. (Exemple : l'éducation thérapeutique d'un patient souffrant de la tuberculose).

2.2.4 Prévention quaternaire

C'est l'ensemble des soins auprès des malades qui ont dépassé le stade des soins curatifs et qui se trouvent en phase terminale (les soins palliatifs).

III. DIFFERENCES ENTRE SANTE PUBLIQUE ET SANTE COMMUNAUTAIRE

Le concept de santé communautaire tend à remplacer celui de santé publique. Pourtant, il existe une différence entre ces deux concepts qui sont complémentaires. Le terme de **santé communautaire** introduit une notion d'engagement de chaque individu alors que celui de **santé publique** fait appel à une notion de puissance publique, représentante d'une collectivité.

- Tableau qui résume la différence entre santé publique et santé communautaire

	Santé Publique	Santé Communautaire
Finalité	La protection de la santé de la population.	La promotion de la santé
Niveau de décision	Il se situe niveau de l'Etat ou de ses représentants (Maire, Sous-préfecture, etc.)	Il se situe au niveau de la communauté
Les deux approches sont complémentaires		

IV. GRANDS COURANTS AYANT MARQUE L'HISTOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE

4.1 Période de l'antiquité (~3500 ans à 476)

Elle est marquée par l'apparition des notions d'hygiène et de contrôle des maladies infectieuses. Elles ont pris forme avec la construction d'aqueducs (tuyau traditionnel) par la population pour amener l'eau dans les villes afin de prévenir les maladies et aussi, disposer de réseaux d'évacuation des eaux usées.

4.2 Période du moyen âge : (476 à 1492) : Apparition du précepte de l'hygiène.

4.3 De la période du moyen âge à la fin du temps moderne (476 à 1789)

Cette période a été marquée par l'apparition des concepts comme endémies et épidémie. Ainsi, la première préoccupation de la santé publique fut la prévention des épidémies.

4.4 Période contemporaine (de 1796 à nos jours):

- ✓ *Du milieu du 19^{ème} siècle à la fin du 19^{ème} (du milieu de l'année 1801 à la fin des années 1900.)*

Cette période a été marquée par :

- Le développement de l'hygiène publique (apparition des notions comme la contamination et les théories microbiennes des maladies contagieuses avec Semmelweis, Davaine et Louis Pasteur.
- La création de la Charte de l'hygiène publique en France.
- L'établissement de lien entre les conditions sociales et la santé avec l'apparition du courant de pensée « santé de la population, préoccupation sociale ». La santé des populations notamment les groupes vulnérables devinrent la responsabilité de l'Etat.
- La création du concept « **Education pour la santé** ». Celui-ci va changer complètement le profil épidémiologique des maladies en Europe avec la réduction des maladies infectieuses, la raréfaction des épidémies et la baisse de la mortalité.

- ✓ *De la fin de la 2^{ème} décennie (1920) au milieu de la 5^{ème} décennie (1945) du 20^{ème} siècle.*

A cette période, nous avons assisté en :

- **1920** : Définition du concept de « santé publique » par WILSON
- **1945** : Apogée de la science médicale qui va entraîner du coup la passivité des populations à améliorer leur comportement.

Cette situation va avoir pour conséquence une montée des maladies chroniques pour lesquelles les comportements jouent un rôle déterminant.

- 1946 : institution de la santé par l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)
l'objectif est possible en raison de conditions sociales et politiques.
l'amélioration de la santé s'est par ailleurs vu encouragée par progrès médicaux, mais la réduction de conditions sociales de santé de vie économique, sociale et culturelle favorables à la santé.

4.5 De la fin de la seconde guerre mondiale aux années 1970 (1945 à 1970)

Elle est marquée par l'avènement des systèmes de santé.

A cette période, nous allons assister à un essor fulgurant des services de santé : une forte demande de soins provoque conséquemment l'accroissement de celle de l'Etat et une organisation des services de santé.

Les dates qui ont marquées cette période sont :

- 1977 : apparition du mouvement « santé pour tous » suite aux inquiétudes flagrantes constatées dans l'offre des soins.
- 1978 : à la Conférence internationale d'Alma-Ata, les soins de santé primaires ont été choisis pour accompagner le mouvement « santé pour tous ».

4.6 A partir des années 80 (1980 à 1990)

Les événements ayant marqué cette décennie sont :

- 1986 : l'avènement de la Charte d'Ottawa pour promouvoir le concept promotion de la santé. Cette approche va modifier les comportements en matière de santé dans le contexte économique et social.
- 1987 : Organisation de la réunion de Bamako (Mali) pour créer de fond l'avènement du concept de participation communautaire dans le langage de la santé publique.

V. EVOLUTION DU CONCEPT DE SANTE PUBLIQUE

La définition du concept de santé publique a évolué depuis celle de Winslow en 1920. Aujourd'hui, elle va au-delà d'un simple concept. C'est une philosophie qui s'efforce d'élargir l'ancienne compréhension de la santé publique pour fournir un accès équitable aux services de santé tout en prenant en compte la gouvernance politique, l'environnement, le développement social et économique.

VI. EVENEMENTS AYANT MARQUE L'HISTOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE

De nombreux événements ont marqué l'histoire de la santé publique dans le monde depuis le VII^{ème} siècle jusqu'au XXI^{ème} siècle. Ces événements sont matérialisés dans la figure ci-après.

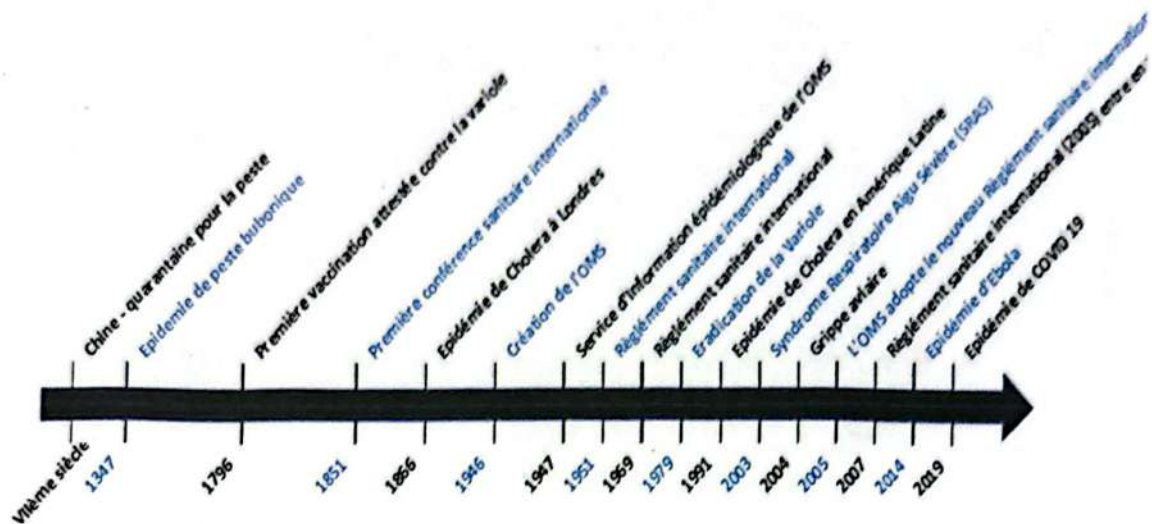


Figure n°1 : Chronologie des événements de santé qui ont jalonné l'histoire du monde

VII. ETAPES DE LA DEMARCHE DE SANTE PUBLIQUE

Elle consiste en une série d'actions menées par les autorités étatiques pour répondre aux besoins de santé de la population. Les différentes étapes de la démarche de santé publique sont :

1. Analyse de la situation et identification du ou des problèmes de santé ;
2. Définition des priorités (problème prioritaire);
3. Formulation du problème et détermination de la population cible ;
4. Formulation des objectifs ;
5. Choix des stratégies (activités) ;
6. Identification des ressources (financières, matérielles, humaines, temporelles) ;
7. Etablissement d'un plan d'action opérationnel ;
8. Exécution du programme établi ;
9. Suivi et évaluation du programme.

VIII. NIVEAUX DE PERCEPTION DES BESOINS DE SANTE

Il existe trois niveaux de perception des besoins de santé :

- Le niveau des besoins latents ;
- Le niveau des besoins ressentis ;
- Le niveau des besoins exprimés

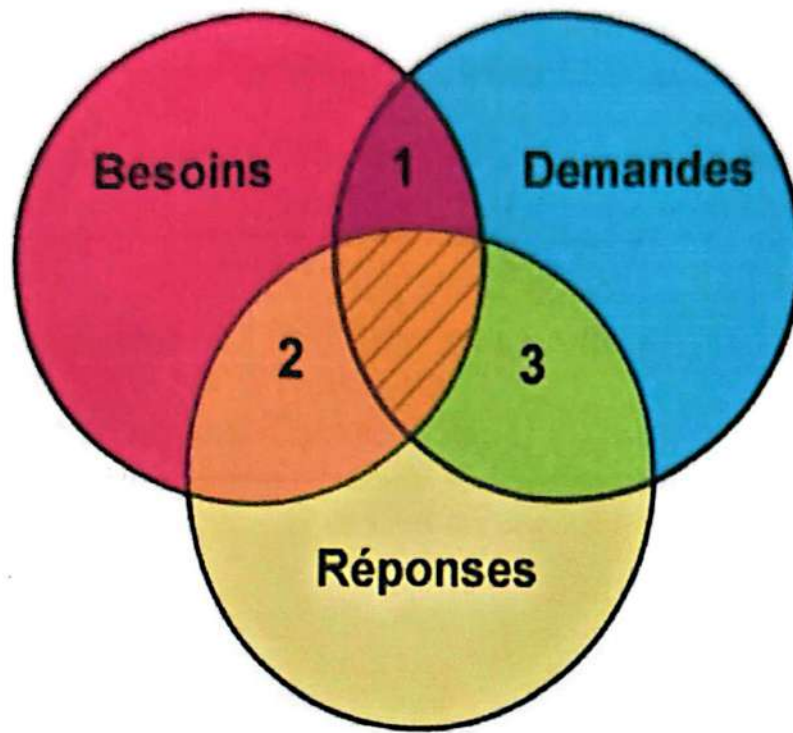


Figure n° 2 : Représentation des trois niveaux de perception des besoins

❖ Explication

L'intersection (1) correspond à des besoins et des demandes, mais pas de réponse. A ce niveau, les besoins existent, les demandes sont exprimées par les populations, mais le système de santé n'est pas en mesure d'apporter des réponses satisfaisantes.

Exemple : le besoin pour le traitement de l'hépatite B existe dans la population, la demande est exprimée, mais pas de médicaments pour satisfaire ce besoin.

L'intersection (2) correspond à des besoins identifiés, des réponses existent mais l'on note une absence de demande.

A ce niveau, il y a un risque de sous-utilisation des services de santé soit parce qu'elles ne sont pas connues par la population, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles pour des raisons financières, culturelles ou géographiques

Exemple : il y a un besoin en dépistage du cancer de col de l'utérus dans la population, les services et le matériel existent, mais la population ne fréquente pas les centres de dépistage.

L'intersection (3) correspond à une réponse à des demandes, sans besoin identifié. Ce niveau correspond à du gaspillage.

Exemple : l'utilisation excessive des antibiotiques pour des épisodes infectieux d'origine virale pour lesquels les antibiotiques n'ont aucune efficacité.

L'intersection (**hachurée**) entre les trois cercles correspond à la situation idéale. Les besoins existent, les populations font la demande des soins et les réponses à leurs demandes existent

IX. FACTEURS POUVANT INFLUENCER LA MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE

- Les volontés programmatiques des Etats ;
- L'absence de mécanismes de sécurité sociale dans la plupart des PVD ;
- La dépendance des systèmes de soins aux disponibilités budgétaires.

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de connaître le système de santé ivoirien et la politique sanitaire nationale.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Définir les concepts qui composent le système de santé
- 2) Citer deux valeurs et deux objectifs du système de santé
- 3) Enoncer trois fonctions d'un système de santé
- 4) Décrire les six piliers d'un système de santé
- 5) Décrire les caractéristiques d'un système de santé
- 6) Décrire les différentes périodes du système sanitaire ivoirien : la période d'avant l'indépendance et la période post-indépendance
- 7) Décrire le système de santé Ivoirien
- 8) Enoncer les problèmes prioritaires actuels du système de santé ivoirien
- 9) Enoncer le rôle des partenaires mondiaux du système de santé de Côte d'Ivoire

INTRODUCTION

La santé est un droit fondamental de tout être humain et un objectif de portée sociale. Les Etats ont l'obligation d'assurer à la population et de façon équitable un état de santé optimal qui lui permette de mener une vie socialement et économiquement productive, quel que soit sa race, son ethnie, sa couleur de peau, son sexe, son origine sociale, sa religion ou croyance, son opinion, sa fortune, sa différence de culture ou de langue, sa situation sociale ou son état physique ou mental.

Pour assurer ce rôle régalien, les Etats se dotent d'un système de santé comme ce fut le cas de la Côte d'Ivoire. Etant donné l'importance de l'histoire pour mieux comprendre le présent et envisager l'avenir, il est nécessaire que la genèse du système de santé Ivoirien soit connue des futurs professionnels de santé.

I. DEFINITIONS DES CONCEPTS DE BASE DU SYSTEME DE SANTE

1.1. Système

Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles. Il est déterminé par la nature de ses éléments constitutifs, les interactions entre ces derniers et le critère d'appartenance au système (Achouri H., 2014).

1.2. Santé

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. (Constitution de l'OMS).

1.3. Système de santé ou système de soins

L'OMS a défini le système de santé comme « la totalité des organisations, institutions et ressources consacrées à la production d'actions visant principalement à améliorer, maintenir ou restaurer la Santé (OMS, 19 Aout 2022) »

* II. OBJECTIFS D'UN SYSTEME DE SANTE

Un système de santé a trois objectifs

- Améliorer et maintenir l'état de santé pour obtenir un niveau optimal d'état de santé, distribué équitablement ;
- Viser une contribution équitable au financement pour atteindre un degré adéquat de protection financière pour tous contre les risques ;
- Assurer la réactivité du système de santé pour atteindre le niveau le plus élevé possible de satisfaction des consommateurs. (OMS, 2000)

* III. FONCTIONS D'UN SYSTEME DE SANTE

Un système de santé a quatre (04) fonctions

- La prestation de service ;
- La mobilisation des ressources ;
- Le financement ;
- La gouvernance.

3.1 La prestation de service

La prestation de services de santé personnels et non personnels consiste à mettre à disposition de la population les services de santé nécessaires (préventifs, curatifs, diagnostics, réhabilitation) ;

Les interventions cliniques ciblent les patients alors que les autres services de santé sont destinés à l'ensemble de la population ;

La fonction prestation de services du système de santé est la plus connue et est de ce fait considérée souvent comme la totalité du système de santé.

3.2 La mobilisation des ressources

Créer et mobiliser les ressources nécessaires au fonctionnement du système et notamment

- Les ressources humaines ;
- L'infrastructure ;

- Les technologies ;
- Les médicaments ;
- Les vaccins

3.3 Le financement

- Organiser le financement
 - Collecte des recettes ;
 - Mise en commun et répartition des fonds ;
 - Achat de prestations.
- Le financement du système de santé reste plus que jamais à l'ordre du jour pour mieux mettre en œuvre une meilleure mobilisation et allocation des richesses faisant du droit aux soins une réalité pour tous.

3.4 La gouvernance

- Gérer le système de santé (stewardship).
- L'Etat est particulièrement appelé à exercer cette fonction d'administration générale, mais les assureurs et praticiens privés l'exercent aussi dans une mesure légèrement restreinte.
- Une grande partie de l'administration générale consiste à réglementer (l'Etat ou d'autres organismes).

❖ IV. PILIERS D'UN SYSTEME DE SANTE (6 piliers)

4.1 Prestation de services

Les bons services de santé sont ceux qui assurent des interventions de santé personnelles et non personnelles efficaces, sûres et qualitatives aux personnes qui en ont besoin, quand et où elles sont nécessaires avec un gaspillage de ressources minimum.

4.2 Personnels de santé

Les personnels de santé performants sont ceux qui ouvrent de manière réactive, juste et efficace en vue d'obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de santé.

4.3 Information sanitaire

Un système d'information de santé qui fonctionne bien est celui qui assure la production, l'analyse, la diffusion et l'utilisation de l'information fiable et disponible en temps sur les déterminants de la santé, la performance du système de santé et l'état de santé.

4.4 Techniques et produits médicaux essentiels

Un système de santé qui fonctionne bien assure un accès équitable aux produits médicaux, vaccins et technologies essentielles dont la qualité, la sécurité, l'efficacité et la rentabilité sont assurées et dont l'utilisation est scientifiquement saine et rentable.

4.5 Financement de la santé

Un bon système de financement de la santé récolte les fonds sanitaires adéquats de manière à assurer que les populations puissent recourir aux services nécessaires et stimule la prestation de service assurant efficacité pour les prestataires et les bénéficiaires.

4.6 Leadership et gouvernance

Le Leadership et la gouvernance impliquent d'assurer l'existence de cadres de travail relatifs aux politiques stratégiques et que ces derniers soient combinés à une supervision, une dynamique collative, une réglementation, une attention à la conception du système et une recevabilité efficace.

V. CARACTERISTIQUES OU VALEURS D'UN BON SYSTEME DE SANTE

5.1. La globalité

Un système de santé est dit global lorsque dans son fonctionnement il intègre à la fois des activités de promotion de la santé, de prévention de la maladie, des soins curatifs et de réadaptation sociale.

5.2. L'accessibilité

Un système de santé doit être physiquement et financièrement accessible à tous.

5.2.1 L'accessibilité physique

Elle consiste à construire des structures de santé à proximité de chaque localité habitée ou à rapprocher les soins de santé (moins de 5km) des populations par la stratégie avancée

(entre 5 à 15km) ou mobile (plus de 15 km).

5.2.2 L'accessibilité financière

Elle consiste à offrir les soins de santé aux populations à moindre coût.

5.3 L'équité

Un système de santé est dit équitable lorsqu'il est accessible à tous dans les mêmes proportions sans discrimination.

5.4. L'acceptabilité

Un système de santé est acceptable lorsque les méthodes utilisées sont compatibles avec les caractéristiques culturelles et les ressources de la communauté.

5.5. L'efficacité

Un système de santé est efficace lorsqu'il produit les résultats attendus. Un tel système est capable de produire les meilleurs résultats possibles par rapport aux efforts fournis. Cette efficacité peut être mesurée par le calcul des indicateurs (Ex. le taux de mortalité).

5.6. L'efficience

Un système de santé efficient ou productif est un système de santé qui permet d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour le plus faible coût possible.

5.7 Le caractère planifiable et évaluable

Un système de santé est dit planifiable lorsqu'il permet de déterminer les ressources disponibles et de choisir les solutions aptes à résoudre les problèmes de santé de la population. Quant à son caractère évaluable, il tient à la capacité du système de santé à pouvoir apprécier une situation qui prévaut en vue de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs préalablement fixés.

5.8. La réactivité

Un système de santé est dit réactif lorsqu'il peut se modifier constamment pour s'adapter à l'évolution des besoins.

5.9. La liberté

Un système est dit libre lorsqu'il donne d'une part la liberté au malade de pouvoir s'adresser à la structure et à l'agent de santé de son choix.

D'autre part permet à l'agent de santé d'avoir une liberté de prescription. Il reste bien entendu que cette liberté doit être contrôlée pour éviter de mettre en péril la santé des populations.

5.10 La pertinence

C'est l'aptitude du système à agir prioritairement sur les besoins ou problèmes de santé reconnus comme étant les plus importants (problèmes prioritaires), et à cibler les services sur les personnes ou les groupes qui en ont le plus besoin.

VI. HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DU SYSTEME DE SANTE IVOIRIEN

Le système de santé ivoirien est marqué par deux grandes périodes à savoir :

- La période d'avant l'indépendance ;
- La période d'après l'indépendance.

6.1. PERIODE D'AVANT L'INDEPENDANCE.

6.1.1 Organisation du système de santé colonial

L'objectif principal de ce système colonial était de maintenir en bonne santé la main d'œuvre destinée au développement économique qui était prioritaire.

On distinguait certaines structures urbaines destinées aux Européens et Syriens puis d'autres rurales, légères et préventives destinées aux autochtones pour assurer la vaccination, hygiène du milieu et la prophylaxie.

Pour le fonctionnement, ces structures préventives étaient confiées à l'Assurance Médicale Indigène avec son service mobile (1905) et de prophylaxie (1931) pour lutter contre les grandes endémies.

6.1.2 Prestation des services

Les services offerts aux populations étaient constitués par :

- L'organisation de l'hygiène collective ;
- La prophylaxie des grandes endémies.

➤ *L'organisation de l'hygiène collective*

Elle a consisté à déterminer les champs d'activités et les moyens à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre l'insalubrité du milieu de vie. Elle portait sur :

- Le confort et hygiène de l'habitat ;
- L'hygiène en milieu scolaire ;
- L'hygiène au niveau des marchés, etc.

➤ *La prophylaxie des grandes endémies*

Les actions de prophylaxie ont porté sur :

- Le dépistage des cas de maladies ;
- Les mesures préventives : vaccination, isolement etc.
- Le traitement des cas dépistés ;
- Les stratégies fixes et mobiles.

6.1.3 Ressources humaines pour la santé

Les ressources humaines pour la santé étaient en nombre réduit. En 1960, l'effectif global du personnel de santé était moins de 400. Le personnel africain était formé sur le tas. Après à l'école de médecine Jules CARDE de Dakar au Sénégal ouverte en 1918.

De 1958 en 1960, la formation du personnel qualifiée se déroulait en France pour certains et à Dakar pour d'autres.

6.1.4 Financement du système de santé

Le financement du système de santé était assuré par l'administration coloniale.

6.1.5 Infrastructures sanitaires

Le système de santé colonial était caractérisé par une infrastructure minimale de base.

En 1902, il y avait un dispensaire de 23 lits (Grand Bassam)

En 1960 on notait :

- 02 hôpitaux : l'hôpital central du Plateau et l'hôpital annexe de Treichville ;
- 14 centres de santé ;
- 1 service de santé scolaire ;
- 1 service d'hygiène.

6.2. PERIODE POST-INDEPENDANCE

Elle comprend deux (02) périodes :

6.2.1 Période de 1960 à 1980

L'objectif principal de ce système postcolonial était la consolidation des acquis de la période avant l'indépendance :

- Les infrastructures ;
- Le personnel ;
- Le financement

Les structures d'accueil et de soins étaient localisées dans les centres urbains.

➤ Les infrastructures sanitaires

La capacité totale d'hospitalisation était de 6.470 lits entre 1976 et 1980 repartis dans :

- 04 EPHN (Cocody, Treichville, Yopougon, Angré) ;
- 82 EPHR dans les chefs-lieux de préfecture ;
- 720 structures de base (centre de santé dans les Sous-préfectures) ;
- 26 bases de secteur de santé rurale ;

- 01 faculté de médecine à Abidjan ;
- 01 faculté de pharmacie à Abidjan ;
- 01 institut de cardiologie à Abidjan ;
- 01 Service d'Aide Médicale d'Urgence (SAMU) à Abidjan ;
- 01 institut Raoul Follereau à Adzopé (IRF) ;
- 01 institut d'odontostomatologie à Abidjan ;
- 01 Ecole Nationale d'Infirmier et Sage-femme à Abidjan ;
- 01 Institut National d'Hygiène Publique (INHP) à Abidjan ;
- 01 Institut National de Santé Publique (INSP) à Abidjan ;
- 01 Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) à Abidjan.

La prestation des services était organisée selon deux (02) volets :

- Un volet orienté sur les soins curatifs avec pour caractéristique essentielle, la gratuité des soins.
- Un volet préventif basé sur une assistance médicale visant à lutter contre les grandes endémies (pian, trypanosomiase, lèpre, onchocercose etc.) d'où la notion de grandes endémies.

Pendant cette période, l'accent était mis sur les soins curatifs, le renforcement du dépistage des endémies. Elle a été marquée par la chute du cours des produits agricoles contraignant le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'ajustement structurel dans différents domaines dont celui de la santé.

6.2.2. Période de 1991 à 1993

Cette période a été caractérisée par :

- Un environnement physique et économique défavorable ;
- Une prédominance de maladies infectieuses et parasitaires représentant 60% de la mortalité ;
- Une recrudescence et une extension des grandes endémies tels que le pian, la lèpre, la tuberculose, la dracunculose, l'ulcère de Burili... etc.
- Une émergence et une propagation des maladies fortement liées à la modernisation de nos sociétés, à la modification des modes de vie, à l'urbanisation et aux difficultés d'adaptation et d'insertion (HTA, accident de la voie publique, drogue, alcoolisme, stress, troubles psychiques, etc.) ;
- Un taux très élevé de la mortalité maternelle selon les régions ;
- Un taux de mortalité liés au SIDA de 10 à 15% chez les adultes et les jeunes ;
- Une recrudescence de la tuberculose à cause de l'infection à VIH (2 tuberculeux sur 3 sont porteurs du virus de SIDA).

Cette période a également permis :

- de définir d'une véritable politique orientée sur les Soins de Santé Primaires.

- d'accroître et améliorer des infrastructures sanitaires et le développement d'un partenariat avec les divers organismes, partenaires au développement (Banque Mondiale, UNICEF, OMS).

De 1994 à 2006

Les réformes engagées se sont traduites par :

- Le renforcement de la politique des médicaments essentiels génériques par le biais de la Pharmacie de la Santé Publique ;
- Le renforcement de la politique de recouvrement des coûts des actes de santé avec la création de 800 comités de gestion qui participent au choix des priorités pour l'utilisation des ressources additionnelles générées (engendrées) par les formations sanitaires ;
- Le renforcement de la politique de la santé de reproduction SR/PF. Cette politique avait pour objectif d'accorder la priorité à la santé de la mère et de l'enfant comme mentionné dans le document de l'initiative de Bamako (SSP/IB, 1987-1988) ;
- Le renforcement de la politique de réhabilitation des infrastructures sanitaires et des plateaux techniques. Il s'agissait de rendre les structures sanitaires vieillissantes plus fonctionnelles et de doter les formations sanitaires en équipements, en matériels techniques en quantité et en qualité pour un rendement plus efficace ;
- Le renforcement de la politique des Soins de Santé Primaires (SSP).
- La naissance d'un véritable système de santé national et d'une politique de santé.

➤ Infrastructure sanitaire en 2025

SIGLE	DENOMINATION	NOMBRE
ESPC	Etablissement Sanitaire de Premier Contact	3000
EPHD	Etablissement Public Hospitalier Départemental	115
EPHR	Etablissement Public Hospitalier Régional	21
EPHN	Etablissement Public Hospitalier National	05
CHS	Centre Hospitalier spécialisé	05
DDS	Direction Départementale de la santé	113
DR	Direction Régionale	33

Source : DHIS2(2025)

➤ Ressources humaines en 2025

Corps médical	Nombre	Ratio (valeur CI)	Norme OMS
Médecins	6000	1/5697 Habitants.	1/10.000
Infirmiers	26000	1/2300 Habitants	1/3000
Sages-femmes	12000	1/Moins de 700 FAR	1/3000

Source : MSHP-CMU 2025

VII. LE SYSTEME DE SANTE IVOIRIEN

Le Système National de Santé Ivoirien se caractérise par sa forme pyramidale avec trois niveaux (primaire ou périphérique, secondaire ou intermédiaire, tertiaire ou centrale) et deux versants (prestataire et gestionnaire).

Il a une base large correspondant à une multitude de structures sanitaires de premier niveau (ESPC) et un sommet rétrécit avec les structures de santé de pointe (CHU).

VIII. POLES REGIONAUX D'EXCELLENCE EN SANTE

En plus des trois niveaux, le SNS est aussi organisé en pôle sanitaire par l'arrêté N° 203 MSHP-CMU/CAB du 02 Mai 2023 portant création, attribution et organisation des PRES dans la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire.

8.1 Définitions

Les Pôles Régionaux d'Excellence en Santé (PRES) sont des structures fonctionnelles et organisationnelles intégrées créées par l'État ivoirien pour mutualiser les moyens, coordonner les compétences et améliorer la qualité des soins à l'échelle régionale.

8.2 Missions

- Coordonner les acteurs sanitaires régionaux pour une réponse plus harmonisée.
- Mutualiser les ressources humaines, matérielles et financières pour améliorer l'offre de soins.
- Garantir l'accès aux soins de qualité dans un continuum de services, de la prévention aux soins spécialisés.
- Limiter les références sanitaires vers les grandes villes, en renforçant les capacités locales de prise en charge.

8.3 Les 10 Pôles d'excellence en santé

Pôle (PRES)	Régions Sanitaires couvertes	Chef-lieu / Ville Pivot
PRES Abidjan	Abidjan 1 & 2, Agnéby-Tiassa, Grands Ponts, La Mé, Sud-Comoé	Abidjan
PRES Yamoussoukro	Bélier, Marahoué, N'Zi, Loh-Djiboua, Gôh	Yamoussoukro
PRES Bouaké	Gbêkê, Béré, Hambol	Bouaké
PRES Daloa	Haut-Sassandra, Worodougou	Daloa
PRES Korhogo	Poros, Tchologo	Korhogo
PRES San-Pédro	San-Pédro, Gbôklè, Nawa	San-Pédro
PRES Abengourou	Indénié-Djuablin, Moronou, Iffou	Abengourou
PRES Man	Tonkpi, Cavally, Guémon, Bafing	Man
PRES Bondoukou	Gontougo, Bounkani	Bondoukou
PRES Odienné	Kabadougou, Folon, Bagoué	Odienné

IX. LES PROBLEMES PRIORITAIRES DU SYSTEME DE SANTE IVOIRIEN

Des priorités ont été définies au cours de la période 1994-1997. Elles portaient sur :

- Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) ;
- La mise en place d'un système général d'assurance maladie ;
- La promotion des ressources humaines ;
- Le renforcement du système de recouvrement des coûts des actes de santé ;
- L'amélioration et le développement de structures de formation ;
- L'établissement des bases d'une politique axée sur la participation communautaire des Soins de santé ;

En 2024, la Côte d'Ivoire continue de placer la santé de sa population au cœur de ses priorités, avec un accent particulier sur plusieurs axes stratégiques :

9.1. Renforcement de la Couverture Maladie Universelle (CMU) :

- L'objectif principal est d'assurer un accès équitable aux soins de santé pour tous les Ivoiriens.
- Des efforts sont déployés pour augmenter le taux de cotisation, garantir la disponibilité des médicaments, optimiser la digitalisation des données de santé et renforcer l'harmonisation des outils de suivi.

- L'amélioration de l'offre de soins et l'accessibilité sont des éléments clés pour atteindre une réorganisation du système de santé répondant aux besoins de la population.

9.2. Lutte contre le VIH/SIDA :

- La Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre ses efforts pour éradiquer le sida en tant que problème de santé publique.
- Les enfants, les jeunes et les adolescents sont des cibles prioritaires pour les stratégies de prévention.
- L'intensification et la mutualisation des efforts sont essentielles pour assurer une riposte à long terme contre cette pandémie.

9.3. Amélioration du système de santé :

- Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2021-2025 vise à renforcer le système de santé, en mettant l'accent sur les ressources humaines, la gouvernance, l'accès aux médicaments, le système d'information sanitaire et le financement de la santé.
- L'objectif est de rendre le système de santé plus performant, accessible et résilient.

9.4. Les priorités de l'OMS en Côte d'Ivoire :

- Renforcer le système de santé, notamment les ressources humaines pour la santé (RHS), la gouvernance, l'accès aux médicaments, le système d'information sanitaire (SIS), le financement de la santé et s'assurer qu'un plus grand nombre de personnes bénéficie de la Couverture sanitaire universelle (CSU).

En résumé, les priorités de la santé en Côte d'Ivoire en 2024 sont axées sur le renforcement de la CMU, la lutte contre le VIH/SIDA et l'amélioration globale du système de santé, en collaboration avec des partenaires tels que l'OMS.

X. PARTENARIATS MONDIAUX POUR LA SANTE (PMS)

Face aux difficultés économiques de certains pays, l'appui financier des partenaires au développement est sollicité par ces derniers pour améliorer le fonctionnement de leur système de santé dans le cadre de partenariat bilatéral et multilatéral.

LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTE

Le système de santé permet la mise place d'une politique de santé. La politique nationale de santé de la Côte d'Ivoire se décline en programmes de santé et les programmes de santé en stratégies.

Le système de santé ivoirien compte de nombreux programmes de santé (23 actuellement) misent en place en fonction du profil épidémiologique des maladies pour lesquelles ces programmes ont été créés. Tous ces programmes sont importants mais ceux prioritaires pour notre pays sont :

- ✓ Les 03 programmes financés par le Fonds Mondial
 - Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) ;
 - Le Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) ;
 - Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) ;
- ✓ Le Programme National de la Santé de la Mère et de l'Enfant (PNSME) ;
- ✓ Le programme Elargi de Vaccination (PEV).

Dans le cadre de notre enseignement, nous parlerons du Programme Elargi de Vaccination (PEV), du Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) et du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP).

CONCLUSION

Le système de santé ivoirien a une histoire qui mérite d'être connue par l'ensemble des agents de santé qui sont les principaux animateurs du niveau périphérique de ce système de santé.

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de connaître le Programme Elargi de vaccination de Côte d'Ivoire.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Définir les différents concepts liés à la vaccination
- 2) Citer les maladies cibles du PEV
- 3) Décrire les caractéristiques des vaccins du PEV Ivoirien
- 4) Distinguer les différents types de vaccins
- 5) Décrire les différents constituants des vaccins.
- 6) Citer les populations cibles du PEV Ivoirien
- 7) Enoncer les principes de rattrapage et d'association des vaccins
- 8) Décrire l'organisation et le fonctionnement du PEV ivoirien.
- 9) Enoncer les calendriers vaccinaux de l'enfant de 0 à 23 mois, de la femme enceinte et de la jeune fille de 9 ans
- 10) Citer les contre-indications de la vaccination

INTRODUCTION

- Selon les données de l'OMS (2022), plusieurs raisons permettent de justifier l'importance de la formation du personnel de santé sur la vaccination.
- En effet, la couverture vaccinale mondiale a reculé passant de 86% en 2019 à 83% en 2020. En plus, 23 millions d'enfants dans le monde n'ont pas reçu les vaccins de base dans le cadre des services de santé habituels, soit le chiffre le plus élevé depuis 2009 et représente une hausse de 3,7 millions par rapport à 2019.
- En 2020 le nombre d'enfant complètement non vaccination a augmenté de 3.4 millions et 1,6 millions de femmes de plus que l'année 2019 n'étaient pas pleinement protégées contre le virus du papillome humain.

I. DEFINITIONS DES CONCEPTS LIES À LA VACCINATION

1.1. Système immunitaire

Le système immunitaire est le mécanisme de défense que l'on retrouve chez chaque individu et qui aide l'organisme à lutter contre la maladie infectieuse grâce à la production des anticorps qui combattent les germes pathogènes.

1.2. Vaccin

C'est une substance qui détermine dans l'organisme un état de résistance à une maladie donnée en faisant appel à ses défenses propres avec l'avantage d'être plus durable que l'efficacité d'un sérum.

1.3. Sérum

Le sérum est une substance contenant des anticorps et ayant une propriété curative sur un temps relativement court.

1.4. Vaccination

C'est le processus qui consiste à administrer un vaccin en vue de prévenir la survenue d'une ou plusieurs maladies chez un organisme vivant.

1.5. Sécurité des injections

Une injection est dite sécurisée lorsqu'elle est sans risque pour le vacciné, le vaccinateur et la communauté.

1.6. Manifestation adverse post immunisation (MAPI)

C'est une manifestation indésirable qui survient après une vaccination et qui n'est pas nécessairement liée à l'utilisation du vaccin.

1.7. Chaîne de froid

C'est un dispositif continu de conservation de vaccins à une température convenable (entre 2 et 8° C) depuis l'usine de fabrication jusqu'au bras de la personne vaccinée.

II. LES MALADIES CIBLES DU PEV IVOIRIEN

1. La tuberculose ;
2. La diphtérie ;
3. Le tétanos ;
4. La coqueluche ;
5. L'hépatite B ;
6. La méningite à *Haemophilus influenzae* de type B ;
7. La poliomyélite ;
8. La rougeole ;
9. La rubéole ;
10. La fièvre jaune ;
11. La diarrhée à rota virus ;
12. Les infections à pneumocoque (méningites, pneumonies, bactériémies, etc.
13. Le Papilloma Virus Humaine (contre le cancer de col) ;
14. La méningite de type A ;
15. Le paludisme.

III. DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS VACCINS DE PELV

3.1 Le BCG : Bacille de Calmette et Guérin (vaccin contre la tuberculose)

Type de vaccin	Bactérien vivant atténué
Période d'inoculation	A la naissance
Rappel	Aucun
Réactions indésirables	Abscès local, lymphadénopathie régionale ; rarement : propagation à distance engendrant une ostéomyélite, une pathologie généralisée
Précautions particulières	L'Intra Dermo- Réaction (IDR) précise est indispensable. Une seringue et une aiguille spéciales sont utilisées pour l'administration
Dose à injecter	0,05ml
Point d'administration	Face externe du haut du bras ou épaule gauche
Voie d'administration	Intradermique
Conservation	Entre 2°C et 8°C.

3.2 Le Vaccin anti hépatite B pédiatrique

Type de vaccin	Viral vivant atténué.
Présentation	Sous forme liquide en flacon de 10 doses
Période d'inoculation	A la naissance ou dans les 24 à 72 heures qui suivent la naissance pour les enfants nés à domicile (OMS)
Rappel	Aucun
Réactions indésirables	Douleur, gonflement au point d'injection, irritabilité et/ou fièvre ; Réactions allergiques sévères très rares
Contre-indication	Réaction anaphylactique à une dose précédente
Dose à injecter	0,5ml
Point d'administration	Face antérolatérale de la cuisse.
Voie d'administration	Intramusculaire
Conservation	Entre +2°C et 8°C. Ne pas congeler

3.3 Le Penta ou DTCHepHib (vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la méningite à Haemophilus influenzae de type B)

Type de vaccin	Vaccin combiné (anatoxines, viral et bactérien)
Nombre de doses	Trois
Période d'inoculation	6,10 et 14 semaines après la naissance
Contre-indications	Ne pas utiliser à la naissance
Réactions indésirables	Réactions locales ou générales bénignes sont fréquentes
Dose à injecter	0,5 ml
Point d'administration	Chez le nourrisson : à mi-hauteur de la face externe de la cuisse/ Chez l'enfant : à la face externe du haut du bras
Voie d'injection	Intramusculaire
Conservation	Entre 2°C et 8°C.

3.4 Le VPO : Vaccin Polio Oral (vaccin contre la poliomyélite)

Type de vaccin	Vaccin viral vivant atténué
Nombre de doses	Quatre dans les pays d'endémie (y compris la dose administrée à la naissance)
Période d'inoculation	Naissance, 6,10 et 14 semaines
Réactions indésirables	Très rarement, une poliomyélite paralytique (environ 2 à 4 cas par million d'enfants vaccinés)
Précautions particulières	Les enfants qui présentent des syndromes d'immunodéficience congénitale rare doivent recevoir le VPI plutôt que le VPO
Dose à injecter	2 gouttes
Rappel	Doses supplémentaires administrées dans le cadre des activités d'éradication de la poliomyélite
Conservation	Entre 2°C et 8°C.

3.5 Le VPI : Vaccin Polio Inactivé

Type de vaccin	Vaccin viral inactivé
Nombre de doses	Deux
Période d'inoculation	6 et 14 semaines après la naissance
Présentation	Sous forme injectable
Réactions indésirables	Très rarement, une poliomyélite paralytique (environ 2 à 4 cas par million d'enfants vaccinés)
Précautions particulières	En cas de doute sur la congélation d'un flacon, il ne doit pas être utilisé. Ne jamais injecter le vaccin dans la fesse.
Volume de la dose	0,5 ml
Rappel	Aucun
Point d'administration	La face antéro externe de la cuisse droite
Voie d'administration	Intra musculaire (IM)
Conservation	Entre 2°C et 8°C. Il ne doit pas être congelé

3.6 Le Rotarix (vaccin contre la diarrhée à rotavirus)

Type de vaccin	Un vaccin viral vivant atténué.
Présentation	Sous forme liquide en flacon monodose (tube de 2ml)
Précautions particulières	En cas de diarrhée, traiter l'enfant et reporter la vaccination à une date ultérieure
Effets secondaires	Parfois l'irritabilité et la perte de l'appétit, diarrhée immunodépression et vomissements.
Contre-indications	Hypersensibilité après une administration antérieure du vaccin, antécédent d'invagination intestinale.
Nombre de doses	Deux
Période d'inoculation	6 et 10 semaines après la naissance
Rappel	Aucun
Dose à injecter	2 ml
Voie d'administration	Orale
Conservation	Entre 2°C et 8°C.

3.7 La PCV13 : Vaccin antipneumococcique conjugué

(Vaccin contre les Infections à pneumocoque (méningites, pneumonies, bactériémies, otites moyennes, sinusites et bronchites).

Type de vaccin	Vaccin conjugué à la protéine de polysaccharide
Présentation	Sous forme liquide en flacon monodose
Nombre de doses	Trois
Période d'inoculation	6,10 et 14 semaines après la naissance
Rappel	Aucun
Contre-indications	Hypersensibilité connue à une dose antérieure
Réactions indésirables	Réactions locales (rougeurs, douleurs et tuméfactions), fièvre
Dose à injecter	0,5 ml
Point d'administration	Le muscle antérolatéral de la cuisse
Voie d'administration	Intramusculaire
Conservation	Entre 2°C et 8°C. Ne jamais congeler

3.8 Le RR : (Vaccin contre la Rougeole et la Rubéole)

Type de vaccin	Vaccin viral vivant atténué
Nombre de doses	Une dose, 2 ^{ème} possibilité au plus tôt un mois après la 1 ^{ère} dose
Période d'inoculation	Entre 9 et 11 mois dans les pays où la rougeole est fortement endémique
Rappel	A 15 mois
Réactions indésirables	Malaise, fièvre, rash cutané au bout de 5 à 12 jours, rarement encéphalite, anaphylaxie
Précautions particulières	Aucune
Dose à injecter	0,5 ml
Point d'administration	A mi-hauteur de la face externe de la cuisse Le haut du bras selon l'âge
Voie d'administration	Sous-cutanée
Conservation	Entre 2°C et 8°C.

3.9 Le VAA : Vaccin antiamaril (contre la fièvre jaune)

Type de vaccin	Vaccin viral vivant atténué
Rappel	Aucun
Nombre de doses	Une dose
Réactions indésirables	Hypersensibilité aux œufs ; rarement, encéphalite chez le très jeune enfant ; insuffisance hépatique
Période d'inoculation	A 9 mois avec le vaccin anti rougeoleux
Précautions particulières	Ne pas administrer avant l'âge de 6 mois ; Eviter durant la grossesse
Dose à injecter	0,5 ml
Point d'administration	Haut du bras droit
Voie d'administration	Sous-cutanée
Conservation	Entre 2°C et 8°C.

3.10 Le vaccin Men A (Vaccin contre la méningite de type A)

Type de vaccin	Vaccin bactérien inactivé
Rappel	Aucun
Nombre de doses	Une dose
Effet secondaire	Réaction locale bénigne, fièvre modérée, rougeur, douleur au point d'injection entre 1 à 2 jours
Contre-indications	Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. Réaction sévère après injection antérieure du vaccin.
Période d'inoculation	A 9 mois avec le vaccin anti rougeoleux et anti amaril
Précautions particulières	Ne pas administrer avant l'âge de 6 mois
Dose à injecter	0,5 ml
Point d'administration	Haut du bras droit
Voie d'administration	Sous-cutanée
Conservation	Entre 2°C et 8°C.

3.11 Le Td de la femme enceinte (Vaccin contre le tétanos et la diphtérie)

Type de vaccin	Anatoxine
Rappel	06 mois après la 2 ^{ème} dose
Nombre de doses	Au moins deux doses initiales (trois doses pdt la grossesse)
Réactions indésirables	Réactions locales ou générales bénignes courantes dont la fréquence augmente avec le nombre de doses
Période d'inoculation	Dès le premier contact avec un service de vaccination
Précautions particulières	Diminuer la teneur en anatoxine
Volume de la dose	0,5 ml
Point d'administration	Face externe du haut du bras
Voie d'administration	Intramusculaire
Conservation	Entre 2°C et 8°C. Ne pas congeler

3.12 Le HPV : Vaccin contre le Papilloma Virus Humain (cancer de col)

Type de vaccin	Vaccin viral quadrivalent inactivé
Présentation	Sous forme liquide en flacon d'une dose (monodose)
Nombre de doses	Une seule dose (jeune fille saine) ou trois doses (jeune fille positive)
Population cible	Jeunes filles âgées de 9 ans
Dose recommandée	0,5 ml
Point d'administration	Région du deltoïde (partie supérieure) du bras gauche.
Voie d'administration	Intramusculaire
Conservation	Entre +2°C et +8°C. Ne pas congeler

3.13 Le vaccin contre le paludisme (Matrix R21)

Type de vaccin	Protéine recombinante avec adjuvant Matrix-M
Présentation	Sous forme liquide en flacon de 02 doses avec la PCV placé sur la tête du flacon
Nombre de doses	04 doses
Population cible	6, 8, 9 et 15 mois
Dose recommandée	0,5 ml
Point d'administration	Face antérolatérale de la cuisse gauche.
Voie d'administration	Intramusculaire à la face antéro latérale de la cuisse
Conservation	Entre +2°C et +8°C.
Contre-indications	Hypersensibilité sévère connue : • A une dose antérieure du vaccin contre le paludisme • A une dose antérieure du vaccin contre l'hépatite B • A l'un des composants du vaccin
Effets secondaires	• Fièvre • Douleur ou léger gonflement au point d'injection • Convulsion (Moins fréquent)
Particularité du vaccin	• Vaccin liquide mais ne se conserve pas • Jeter 6 h après ouverture du flacon • Sensible à la chaleur et à la congélation

IV. LES DIFFERENTES TYPES DE VACCINS

Les vaccins peuvent être préparés de différentes manières. Toutes les techniques visent à diminuer ou supprimer le pouvoir pathogène (qui provoque le développement de la maladie) de l'agent infectieux ou de la toxine contenu dans le vaccin, tout en gardant son pouvoir immunitaire.

4.1. Vaccin vivant atténué

C'est un vaccin contenant une forme atténuée de l'agent infectieux. Le virus ou la bactérie est atténué par divers procédés afin que son agressivité vis-à-vis de l'organisme soit faible, voire nulle.

4.2. Vaccin inactivé (ou tué)

C'est un vaccin contenant une forme inactivée de l'agent infectieux. Le virus, la bactérie ou la toxine est inactivée (on dit aussi "tué"), généralement sous l'effet d'un produit chimique. On évite ainsi qu'il se multiplie et provoque la maladie.

4.3. Les anatoxines

C'est un vaccin qui est synthétisé à partir de la toxine de l'agent infectieux dont on a détruit la toxicité.

4.4. Vaccins conjugués

Ils contiennent un antigène de l'agent infectieux associé à une protéine porteuse. Cette technique permet d'induire une meilleure réponse immunitaire chez l'enfant, même très jeune. Enfin, certains vaccins récents sont fabriqués par génie génétique, c'est-à-dire qu'ils contiennent une partie du virus, de l'enveloppe du virus ou de la bactérie, reconstitué par génie génétique.

4.5. Les Protéines recombinées

La nouvelle génération de vaccins vivants fabriqués par génie génétique. La bactérie ou le virus entier n'est pas inoculé mais simplement une de ses protéines, par exemple la protéine de surface. La protéine est préparée à partir du gène que l'on rend capable de se multiplier à grande échelle. La multiplication est assurée en laboratoire sur des cellules réceptrices (bactéries, levures, cellules animales, etc.).

V. LES DIFFERENTS CONSTITUANTS DES VACCINS

5.1. Les agents pathogènes

C'est le principal ingrédient de la plupart des vaccins. Cet agent peut être un virus ou une bactérie tuée ou atténuée ou une partie de cet agent (toxine) qui stimule le système immunitaire pour qu'il puisse reconnaître et prévenir la maladie à l'avenir.

5.2. Les principaux ingrédients contenus dans les vaccins

Chaque vaccin contient une qualité infime d'ingrédients qui sont.

- L'eau stérile ou une solution salée que renferment habituellement les vaccins.
- Un agent de conservation ou un antibiotique qui empêche la contamination du vaccin par des bactéries
- Des stabilisants, qui permettent de maintenir la qualité du vaccin pendant son entreposage.
- Des adjuvants qui sont des substances qui stimulent la réponse immunitaire du vaccin, ce qui le rend plus efficace.

5.3. Tableau récapitulatif des types de vaccins du PEV ivoirien

N°	Vaccin	Viral	Bactérien	Anatoxine	Vivant atténué	Inactivé	Conjugué	Protéine recombinée
1	BCG							
2	VPO							
3	VPI							
4	Hépatite B pédiatrique							
5	Penta							
6	PCV-13							
7	VAP							
8	RR							
9	HPV							
10	Td							
11	Méningite A							
12	VAA							
13	Rotarix							

VI. POPULATION CIBLE VACCINALE EN COTE D'IVOIRE

6.1. La population cible vaccinale

- L'enfant de 0 à 23 mois ;
- La femme enceinte ;
- La jeune fille de 9 ans

VII. CALENDRIERS VACCINAUX

7.1. Calendrier vaccinal de l'enfant de 0 à 23 mois

Age	Contacts	Vaccins	Maladies
Naissance	1er Contact	DN-Hep B, BCG, VPO ₀	Hépatite Virale, Tuberculose, Poliomyélite
6 semaines	2 ^{ème} contact	DTC-Hép B-Hib, VPO1, PCV13-1, Rota1, VPI 1	Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Hépatite virale B, Poliomyélite, Méningite à <i>hémophilus influenzae</i> de type B, Méningite à pneumocoques et infections respiratoires aiguës, Diarrhées à rotavirus
10 semaines	3 ^{ème} contact	Penta 2, VPO 2, PCV13-2, Rota2	
14 semaines	4 ^{ème} contact	Penta 3, VPO3, PCV13-3, VPI 2	
6 mois (24 semaines)	5 ^{ème} contact	VAP-1	Paludisme
8 mois (32 semaines)	6 ^{ème} contact	VAP-2	Paludisme
9 mois	7 ^{ème} contact	RR1, VAA, Men A, VAP-3	Rougeole, Rubéole, Fièvre Jaune, méningite de type A, Paludisme
15 mois	8 ^{ème} contact	RR2 & VAP-4	Rougeole, Rubéole, Paludisme

7.2. Calendrier vaccinal de la femme enceinte

Période	Antigène à administrer	Durée de protection
A la 1 ^{ère} CPN	1 ^{ère} dose de Td	Pas de protection
4 semaines après le Td 1	2 ^{ème} dose de Td	3 ans
6 mois après le Td 2	3 ^{ème} dose de Td	5 ans
1an après le Td 3	4 ^{ème} dose de Td	10 ans
1an après le Td 4	5 ^{ème} dose de Td	Protection à vie

7.3. Calendrier vaccinal des Jeunes filles de 9 ans

Age	Antigène à administrer
9 ans (jeune fille)	HPV (dose unique)
09 ans avec VIH positif	HPV1 (9ans)
	HPV2 (2mois après la 1 ^{ère} dose)
	HPV3 (4mois après la 2 ^{ème} dose)

VIII. CONTRE-INDICATIONS VACCINALES

8.1. Contre-indications temporaires

- Maladie grave nécessitant une hospitalisation ;
- Une fièvre de plus de 39°C sauf en cas d'épidémie ;
- Altération de l'état général de l'enfant.

8.2. Contre-indications définitives

- Ne pas administrer la 2^e ou la 3^e dose d'un vaccin si la première ou la deuxième a provoqué chez l'enfant des convulsions ou un choc grave ;
- En cas de signes ou symptômes avérés de SIDA chez un nourrisson, ne pas administrer le BCG (tuberculose) ou le vaccin anti-amaril (fièvre jaune).

IX. PRINCIPALES PERIODES DE RATRAPAGE DES VACCINS ET ASSOCIATIONS VACCINALES

9.1. Période de rattrapage des cibles du PEV

Antigène	Calendrier vaccinal		Période de rattrapage
	Nombre de dose	Age d'administration	
Hépatite B à la naissance	1 dose	A la naissance (24h de vie)	Jusqu'à 72h de vie
BCG	1 dose	A la naissance	Jusqu'à 23 mois
VPO zéro	1 dose	A la naissance	Jusqu'à 2 semaines
VPO	3 doses	6 semaines (1 mois et ½) 10 semaines (2 mois et ½) 14 semaines (3 mois et ½)	Jusqu'à 23 mois
VPI	02 doses	6 semaines (1 mois et ½) 14 semaines (2 mois et ½)	Jusqu'à 23 mois
DTCHepBHib	3 doses	6 semaines (1 mois et ½) 10 semaines (2 mois et ½) 14 semaines (3 mois et ½)	Jusqu'à 23 mois
Rota	2 doses	6 semaines (1 mois et ½) 10 semaines (2 mois et ½)	Jusqu'à 23 mois
PCV13	03 doses	6 semaines (1 mois et ½) 10 semaines (2 mois et ½) 14 semaines (3 mois et ½)	Jusqu'à 23 mois
Rougeole/Rubéole	02 doses	9 mois 15 mois	Jusqu'à 23 mois
Méningite A	01 dose	09 mois	Jusqu'à 23 mois
VAA	01 dose	09 mois	Jusqu'à 23 mois
HPV	01 dose	9 ans (dose unique)	Jusqu'à 14 ans
HPV (jeune fille séropositive)	03 doses	9 ans 2 mois après la 1 ^{ère} dose 4 mois après la 2 ^{ème} dose	Jusqu'à 14 ans

Antigène	Calendrier vaccinal		Période de rattrapage
	Nombre de dose	Age d'administration	
Td	05 doses	1 ^{er} contact 1 mois après la 1 ^{ere} dose 6 mois après la 2 ^{ème} dose 1 an après la 3 ^{ème} dose 1 an après la 4 ^{ème} dose	Jusqu'à 3 ans après l'accouchement

➤ **Disposition Particulier du rattrapage**

- L'enfant de 0 à 23 mois sera vacciné avec TOUS les vaccins de routine selon le calendrier vaccinal du PEV
- Tous les enfants âgés de 24 à 59 mois non à jour de leur vaccins (Penta, VPI, RR, Men A, VAA et le VPO)
- La jeune fille de neuf ans pour le HPV
- La femme enceinte pour le tétanos

➤ **Comment vacciner les enfants de 24 à 59 mois**

- Pendant le rattrapage, vérifier le statut vaccinal de l'enfant dans son carnet ou sa carte de vaccination ;
- En absence de carnet ou de carte s'en tenir à la déclaration des parents

Statut vaccinal de l'enfant	Conduite à tenir
Aucun vaccin fait Age compris entre 24 à 59 mois	• 1^{er} contact administrer Penta1+MenA+RR I +VAA+ VPI+VPO • Donner RDV pour le prochain passage en respectant l'intervalle de 4 semaines
Enfant incomplètement vacciné Age de 24 à 59 mois	• Continuer la série vaccinale selon le calendrier et donner le rendez-vous en respectant l'intervalle de 4 semaines • Pour un enfant n'ayant pas atteint 9 mois, il faut lui administrer le Penta en priorité ; • Pour un enfant ayant atteint 9 mois, il faut lui administrer le RR en priorité • Donner RDV pour le prochain passage en respectant l'intervalle de 4 semaines

9.2. Associations vaccinales

Elles peuvent se faire de façon combinée ou de façon successives.

9.2.1 Association combinée

Il s'agit d'un ensemble d'antigènes associés dans le même flacon depuis le laboratoire de synthèse du vaccin.

Dans ce cas les différents antigènes sont administrés le même jour, au même point d'injection et par la même voie d'injection.

Exemple d'associations combinées : Pentavalent, RR.

9.2.1. Association successive

Il s'agit de l'administration de plusieurs antigènes à un organisme le même jour.

Dans ce cas les différents antigènes peuvent provenir de flacons différents et avoir des voies et des sites d'administration différents.

Exemple d'associations successives : Pentavalent+VPO0+BCG

Les associations successives doivent être faites le même jour pour éviter les interférences entre les vaccins.

En cas d'oubli d'un vaccin devant être pris en compte dans l'association, il faut le faire au moins 4 semaines après.

X. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME

ELARGI DE VACCINATION IVOIRIEN

Créé en 1978, sur recommandation de l'OMS, la phase pilote du programme élargi de vaccination (PEV) a démarré à Abengourou, puis s'est étendu progressivement dans le reste du pays, pour couvrir en 1986, les 28 bases de secteur de santé rurale existantes. A son lancement, c'est l'INHP qui assurait la gestion jusqu'à 1993. C'est en 1994 qu'une direction exécutive du PEV (DEPEV) a été créée pour assurer la coordination du PEV.

Cette direction a été érigée en direction de coordination du programme élargi de vaccination (DC PEV) en 2001 par l'arrêté n° 2001-381/MSP/CAB du 17 décembre 2001, portant organisation et fonctionnement du PEV. En 2009, l'arrêté n° 117 du 6 mai 2009, portant organisation et fonctionnement du PEV, a conféré à la DCPEV d'autres attributions telles que la gestion et la maintenance des équipements, l'approvisionnement et la gestion des vaccins et autres intrants.

La DC PEV est située au 25, Boulevard de Marseille, Abidjan sur la voie qui mène vers le centre national de transfusion sanguine.

10.1. Organisation

Les services de la DC PEV sont :

1. Le service de la communication ;
2. Le service de la logistique ;
3. Le service de surveillance épidémiologique ;
4. Le service de suivi et évaluation ;
5. Le service de prestations ;
6. Le service administratif et financier ;
7. Le service projet et planification.

10.2. Fonctionnement

10.2.1 Missions du PEV Ivoirien

Le PEV Ivoirien a pour principale mission de réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination (MEV). A ce titre, le PEV est chargé :

- D'organiser à l'échelle nationale, la vaccination des populations les plus vulnérables principalement les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes ;
- D'assurer la surveillance des malades cibles du PEV.

10.2.2 Objectifs du PEV Ivoirien

- Assurer la protection par la vaccination de
 - L'enfant de 0 à 23 mois contre 15 maladies
 - La femme enceinte contre 02 maladies
 - La jeune fille de 9 ans contre 01 maladie.
- Contribuer à :
 - L'éradication de la poliomyélite ;
 - L'élimination du tétanos maternel et néonatal (TMN) ;
 - L'élimination de la rougeole ;
 - Au contrôle de la fièvre jaune.

CONCLUSION

Les effets bénéfiques du PEV de notre pays ne sont plus à démontrer. Grâce à la vaccination, la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination ont largement baissées (Ex : la coqueluche), la poliomyélite due au poliovirus sauvage est en phase d'éradication.

Aussi, souhaitons-nous que les étudiants de la L1 s'approprient le contenu de ce cours pour participer à la vaccination pendant leur stage de santé publique.

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de connaître le programme national de lutte contre la tuberculose.

Objectifs spécifiques

A La fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Définir le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT).
- 2) Enumérer les missions du PNL.
- 3) Décrire l'organisation et le fonctionnement du PNL.
- 4) Décrire les stratégies de lutte contre la tuberculose
- 5) Enumérer les objectifs de lutte contre la tuberculose au niveau centrale, intermédiaire et périphérique.
- 6) Citer le rôle de l'infirmier et la sage-femme dans la lutte contre la tuberculose.

INTRODUCTION

La tuberculose est l'une des causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Selon les données récentes de l'OMS, dix (10) millions de personnes ont contracté la tuberculose dans le monde.

Parmi celles-ci, 1 million 500.000 en sont mortes dont 251 000 porteuses du VIH soit un taux de létalité de 15%.

En Côte d'Ivoire, l'incidence de la tuberculose est de 103 cas pour 100.000 habitants, toutes formes confondues.

Pour lutter contre cette maladie, l'Etat a mis en place un Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT).

La Direction de la coordination du programme est située dans l'enceinte du Centre Anti Tuberculeux (CAT) d'Adjamé, sur l'ex-boulevard Nangui Abrogoua.

I. DEFINITION ET CADRE REGLEMENTAIRE

Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (en abrégé PNL) est l'un des programmes verticaux du Ministère de la Santé de L'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle. Il a été créé par arrêté N°279 /MLS/CAB du 08 Août 2001, modifié par l'arrêté N°312/MSHP/ CAB du 04 octobre 2007, lui-même modifié par l'arrêté N°118/MSHP/CAB du 06 mai 2009.

II. MISSIONS DU PNLT

La mission essentielle du PNLT est la mise en œuvre de la politique gouvernementale de lutte contre la tuberculose. A cet effet, il est chargé de :

- Réduire la morbidité et la mortalité liées à la tuberculose, par des activités de type promotionnel, préventif, curatif et de recherche ;
- Contribuer à un meilleur impact de la lutte sur le système de santé.

III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU PNLT

L'organisation et le fonctionnement du PNLT se font autour de deux versants :

- Un versant administratif ;
- Un versant de prestation de soins.

3.3.1 Versant administratif

➤ Le niveau central

✓ *La Direction de la Coordination*

Elle est rattachée au cabinet du Ministre en charge de la santé. Elle est dirigée par un Directeur coordonnateur secondé par un Directeur coordonnateur adjoint. Les deux sont aidés dans leurs tâches par huit chargés d'étude, des médecins, pharmaciens et personnels d'appui. Les services de la direction de coordination sont :

- Le service de formation, de prise en charge et de prévention ;
- Le service d'approvisionnement et de pharmacie ;
- Le laboratoire ;
- Le service de suivi & évaluation ;
- Le service de la tuberculose multi résistante ;
- Le service de la lutte conjointe TB/VIH ;
- Le service de communication et de suivi communautaire ;
- Le service administratif et financier.

A côté de ces services, se trouve un Groupe Scientifique d'Appui constitué d'experts nationaux.

➤ Le niveau intermédiaire

Ce niveau comprend 37 Centres Antituberculeux dirigés chacun par un médecin-chef suppléé dans ses tâches par un médecin adjoint.

➤ Le niveau périphérique

Ce niveau comprend 323 Centres de Diagnostic et de Traitement (CDT) dirigés chacun par un médecin suppléé dans ses tâches par un infirmier diplômé d'Etat ou un infirmier spécialiste en dermato léprologie.

Le médecin responsable du Centre de Diagnostic et de Traitement est chargé de la mise en œuvre des activités de lutte antituberculeuse dans son aire de santé. Il est placé sous l'autorité du Directeur Départemental de la Santé qui est le responsable de la lutte contre la tuberculose dans le district sanitaire.

3.3.2 Versant prestation de soins

➤ Les structures de soins

✓ Le niveau central :

- 03 services de Pneumo-phtisiologie (CHU de Bouaké, Treichville et Cocody) ;
- 01 Centre National de Référence (CNR) logé au sein de l'Institut Pasteur de Côte Ivoire (IPCI).

✓ Le niveau intermédiaire

Il comprend 37 Centre Antituberculeux (CAT) placés sous la direction d'un médecin chef adjoint.

✓ Le niveau périphérique

Il est composé de 323 CDT et de Centres de Traitement (CT). Les CDT sont intégrées dans certains établissements sanitaires.

➤ Le réseau de laboratoires de microscopie

✓ Au niveau central

Au Centre National de Référence (CNR), nous avons une section du laboratoire central de Mycobactériologie de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire.

Le CNR est en liaison avec :

- Le PNLT par l'intermédiaire du service laboratoire ;
- Un laboratoire supra national pour son évaluation externe.

➤ Au niveau Régional

✓ Les laboratoires Régionaux

Ils sont situés dans les centres antituberculeux (CAT) des régions et sont tenus par un bio technologiste.

➤ Au niveau Périphériques

✓ Les laboratoires périphériques

Ils sont installés dans les centres de diagnostic et de traitement (CDT) des districts sanitaires où sont adressés les patients suspects de tuberculose et sont dirigés par des biotechnologies ou des laborantins.

IV. OBJECTIFS DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE AU NIVEAU CENTRAL, INTERMÉDIAIRE ET PÉRIPHÉRIQUE.

Les objectifs sont les mêmes que l'on se situe au niveau central, intermédiaire et périphérique. Les objectifs de luttas sont :

- Taux de succès thérapeutiques des nouveaux cas et rechutes de la tuberculose toute forme confondue : sup ou égal à 89 %
- Taux de décès : inférieur ou égal à 7%
- Taux de perdus de vue : inférieur ou égal à 2%

V. STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

5.1 STRATEGIE DOTS

5.1.1 Contexte

- Environ 1/3 des patients ne prennent pas leurs médicaments régulièrement comme il leur a été prescrit.
- 1/3 de ceux qui en prennent commettent des erreurs lors de l'auto administration

5.1.2 Définition

The Directly Observed Treatment Short-course (D.O.T.S.) ou Traitement Directement Observable (TDO) en français se définit comme « une stratégie globale qui assure la guérison de la plupart des personnes atteintes de tuberculose qui se présentent dans les services des Soins de Santé Primaires » (OMS, 1985)

5.1.3 Buts

- Mettre un terme à l'épidémie mondiale de tuberculose en réduisant le nombre de décès de 95% et l'incidence de 90% entre 2015 et 2035 et en faisant en sorte que plus aucune famille ne supporte de coûts catastrophiques liés à la tuberculose ;
- Éviter le développement des bactéries multi résistantes aux antibiotiques et dû à des traitements anarchiques ;
- Traiter le plus grand nombre à moindre coût, laissant de côté les cas de multi-résistante ayant l'effet pervers de les multiplier.

5.1.4 Eléments de base

La stratégie DOTS repose sur cinq éléments de base :

- L'engagement des pouvoirs publics et des communautés concernant le financement et l'organisation en vue d'assurer des activités durables et complètes de lutte contre la tuberculose ;

- Le dépistage des cas par examen microscopique des frottis d'expectoration de qualité réalisés chez des patients symptomatiques qui se présentent spontanément dans les services généraux de santé ;
- La chimiothérapie standardisée, efficace de brève durée au moyen de schémas thérapeutiques de 6 et 8 mois au minimum pour tous les cas à frottis positif confirmés. La prise en charge correcte comprend un traitement sous observation directe pendant la phase intensive chez tous les nouveaux cas à frottis positif, une phase de continuation avec des schémas thérapeutiques comportant de la rifampicine, et un schéma thérapeutique complet pour le retraitement ;
- L'approvisionnement régulier et ininterrompu des centres de traitement en médicaments antituberculeux essentiels ;
- Un système standardisé d'enregistrement et de notification permettant d'évaluer constamment les résultats du dépistage et du traitement pour chaque patient ainsi que les performances globales du programme de lutte contre la tuberculose.

5.1.5 Aspects de la stratégie

Ils sont d'ordre technique, logistique, opérationnel et politique

✓ Aspect technique

- Dépistage des cas et diagnostic ;
- Chimiothérapie standardisée de courte durée ;
- Observation directe pendant la première phase du traitement (DOT) ;
- Enregistrement et notification des progrès et de la guérison.

✓ Aspect logistique

- Approvisionnement fiable en médicaments et produits de diagnostic ;
- Laboratoires pour l'examen microscopique ;
- Supervision et formation des personnels de santé.

✓ Aspect opérationnel

- Cinq éléments de base ci-dessus cités plus la souplesse dans l'exécution de la stratégie.

✓ Aspect politique

- Engagement des pouvoirs publics ;
- Formulation des politiques ;
- Mobilisation des ressources.

5.1.6 Importance de la stratégie : Elle permet :

- De s'assurer de la prise effective des médicaments ;
- De garantir les chances de guérison ;
- D'éviter la sélection des bacilles résistants ;
- De réduire la morbidité, la mortalité ;
- De raccourcir la période de contagiosité ;
- De rendre un meilleur service au patient et à la communauté.

5.2 STRATEGIE « ENGAGE-TB »

C'est une stratégie lancée par l'organisation mondiale de la santé. Elle consiste à mobiliser et à impliquer aux actions de lutte contre la tuberculose un vaste ensemble d'acteurs participant déjà à des activités communautaires (ONG et autres organisations de la société civile) qui œuvrent dans le domaine des soins de santé primaires, du VIH, de la santé de la mère et de l'enfant, mais qui n'ont pas encore inscrit la tuberculose au nombre de leurs activités.

VI. RÔLE DE L'INFIRMIER, LA SAGE FEMME ET DU MAIEUTICIEN DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Pour une bonne observance du traitement, l'infirmier ou la sage-femme doit :

- Communiquer avec le malade et sa famille, dans un langage simple, accessible, adapté au milieu culturel et au niveau d'instruction ;
- Expliquer la maladie au malade lors du 1^{er} entretien, la contagiosité, les résultats de l'analyse, le traitement et le T.D.O. ;
- Choisir avec le malade le lieu de traitement et répondre à ses questions et préoccupations ;
- Expliquer le plan du traitement...

CONCLUSION

La lutte mondiale contre la tuberculose est confrontée à des difficultés majeures à cause du VIH/SIDA. Cependant beaucoup d'efforts restent à faire pour donner accès à des soins de qualité et lever les obstacles. Dans ce contexte, l'infirmier et la sage-femme ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation et la mise en œuvre des stratégies de lutte.

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de connaître le programme national de lutte contre le paludisme.

Objectifs spécifiques

A La fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Décrire l'organisation et le fonctionnement du PNLP.
- 2) Enumérer les missions du PNLP
- 3) Décrire les stratégies de lutte contre le paludisme

1. CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU PNLP

1.1 Création

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) est l'organe central de coordination de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Créé le 9 mai 1996 par arrêté N° 133 MSP/CAB du 09 mai 1996.

1.2 Organisation

- 01 Directeur Coordonnateur
- 01 Directeur Coordonnateur Adjoint.
- 06 Chargés d'Etudes qui ont la charge des services suivants :
 - Service de la Prise en Charge ;
 - Service de la Communication et du Partenariat ;
 - Service de la Prévention ;
 - Service de l'Epidémiologie, du Suivi, de l'Evaluation ;
 - Service de la Recherche ;
 - Service Administratif et Financier.

1.3 Fonctionnement

Le fonctionnement est régi par l'arrêté n° 311 MSHP/CAB du 04 octobre 2007 modifiant l'arrêté n° 170 MSHP/CAB du 21 juin 2007 portant organisation et fonctionnement du Programme National de Lutte contre le Paludisme,

Dans la conduite des activités, le PNLP est assisté aussi par le Groupe Scientifique d'Appui (GSA) constitué de 18 experts nationaux et un comité de pilotage dont la mission est d'appuyer la mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme.

1.4 Missions

Selon les documents officiels du programme et du Ministère en charge de la Santé, le PNLP a pour missions de :

- Organiser et coordonner la lutte contre le paludisme à l'échelle nationale, en assurant une cohérence des interventions entre les différentes zones et niveaux de la pyramide sanitaire ;
- Élaborer les documents de politique, les normes et les directives techniques qui guident la prévention, le diagnostic, la prise en charge et la surveillance du paludisme à tous les niveaux ;
- Assurer le suivi, l'évaluation et le reporting des interventions de lutte contre le paludisme, afin d'améliorer la performance du programme ;
- Participer activement à la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires, en collaborant avec les partenaires techniques, financiers et les acteurs communautaires pour renforcer la couverture des interventions.

II. METHODES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Les trois méthodes de lutttes contre le paludisme sont :

- La lutte contre les larves de moustiques ;
- La lutte contre les moustiques adultes ;
- La vaccination.

2.1 La lutte contre les larves de moustique : Elle consiste à :

- Vider et enlever tous les récipients pouvant contenir de l'eau ;
- Drainer ou combler les flaques d'eau et autres endroits où l'eau peut stagner ;
- Réparer les fosses septiques et canaux d'élimination des eaux usées très prisés par les moustiques ;
- Curer les caniveaux contenant de l'eau stagnante ;
- Éliminer ou réduire les gîtes de reproduction par le désherbage des pourtours des concessions.

2.2 La lutte contre les moustiques adultes : Il est recommandé de :

- Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ;
- Déposer des grillages aux portes et fenêtres de tous les locaux d'habitations
- Pulvériser l'intérieur des maisons d'insecticides.
- Porter des vêtements longs et clairs à la tombée de la nuit, etc.

2.3 La vaccination (Voir calendrier de vaccination)

GENERALITES SUR L'EPIDEMIOLOGIE

Objectif Général

Ce cours permettra à l'étudiant de la L1 de connaître les notions de base en épidémiologie.

Objectifs spécifiques

Il doit être capable de :

- 1) Définir le terme épidémiologie
- 2) Enumérer les objectifs de l'épidémiologie.
- 3) Citer les domaines d'application de l'épidémiologie.
- 4) Décrire les différents axes en épidémiologie
- 5) Etablir la différence entre l'approche épidémiologique et l'approche clinique des problèmes de santé.
- 6) Décrire les différents phénomènes de masse
- 7) Citer les concepts statistiques utilisés en épidémiologie
- 8) Définir les concepts de base liés à la surveillance épidémiologique

INTRODUCTION

L'épidémiologie est une science fondamentale de santé publique. Elle est très importante dans la formation de l'infirmier et de la sage-femme. Elle contribue à l'amélioration de la santé des populations. Elle est indispensable au processus d'identification et de cartographie des maladies émergentes (OMS, 2010, p.14).

I. DEFINITION

L'épidémiologie est une « discipline scientifique qui étudie la distribution et les déterminants des états de santé et des maladies dans les populations humaines ainsi que des influences qui déterminent cette distribution ». (OMS, 1968).

Les déterminants de la santé sont des facteurs sociaux, économiques, culturels et environnementaux sous-jacents responsables de la santé et de la maladie, dont la plupart se situent dans des secteurs autres que la santé. (OMS, 2010).

II. BUTS

- Comprendre les états de santé et de maladie ;
- Mesurer l'état de santé d'une population ;
- Mesurer les risques individuels et collectifs ;
- Identifier les agents pathogènes, les modes de transmissions et les facteurs de risques, etc.

III. DOMAINES D'APPLICATION

Il existe deux domaines d'application.

- Epidémiologie des maladies transmissibles. *Exemple : la rougeole*
- Epidémiologie des maladies non transmissibles. *Exemple : la malnutrition*

IV. LES DIFFERENTS AXES (Albouty-Llaty, 2009)

- L'axe descriptif : décrit l'état de santé d'une population ;
- L'axe analytique : explique l'état de santé ou analyse les déterminants des problèmes de santé ;
- L'axe évaluatif ou d'intervention : évalue l'impact des interventions (Albouty-Llaty, 2009).

4.1. Axe descriptif

Il étudie la fréquence de la répartition de la maladie ou de la santé dans le temps, dans l'espace et en fonction des caractéristiques de la population (âge, sexe, profession, situation matrimoniale ...) il répond aux questions suivantes :

Quand ? (Temps). Où ? (Lieu). Qui ? (Population cible). Combien ? (Nombre).

4.2. Axe analytique

Il recherche les causes d'apparition de la maladie, du phénomène de santé ou les lie à des facteurs de risque. Elle répond à la question « **Pourquoi ?** »

4.3 Axe évaluatif ou d'intervention

Il évalue le bien-fondé ou non des mesures prises pour améliorer l'état de santé de la population.

V. DIFFERENCE ENTRE L'APPROCHE EPIDEMIOLOGIQUE ET L'APPROCHE CLINIQUE DES PROBLEMES DE SANTE

	Approche épidémiologique	Approche clinique
Sujet d'intérêt (objet)	Maladie	Malade
Diagnostic	Identification d'un phénomène de groupe important	Détermination du sujet d'intérêt clinique
Recherche étiologique	Cause d'apparition de la maladie et de sa propagation dans la Pop	Causes d'apparition de la maladie chez le sujet
Thérapie (intervention)	Contrôle, éradication, élimination maîtrise de la maladie	Guérison du malade
Vérification du succès (évaluation)	Analyse de l'impact des interventions,	Disparition des signes cliniques

VI. LES PHENOMENES DE MASSE

6.1 Epidémie

C'est une apparition soudaine, inattendue d'une maladie dans une population donnée, pendant un temps donné. Elle est limitée dans le temps et dans l'espace.

Exemple : la rougeole.

6.2. Endémie

C'est une maladie qui sévit de manière permanente, continue et constante dans la population et qui est circonscrite à une zone donnée. Elle est illimitée dans le temps mais limitée dans l'espace. **Exemple :** la lèpre.

6.3 Pandémie

C'est une maladie qui touche la population d'un ou de plusieurs continents à la fois, voire la planète. Elle est illimitée dans l'espace mais limitée dans le temps.

Exemple : VIH/SIDA.

Tableau récapitulatif des caractéristiques des phénomènes de masse

Phénomènes de masse	Temps	Espace
Epidémie	Limitée	Limitée
Endémie	Illimitée	Limitée
Pandémie	Limité	Illimitée

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

Objectif général

Ce cours permettra à l'étudiant de la L1 de connaître les mécanismes de conduite de la surveillance épidémiologique.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) Définir la surveillance épidémiologique
- 2) Citer les objectifs de la surveillance épidémiologique
- 3) Décrire les différents types de la surveillance épidémiologique
- 4) Décrire les principaux systèmes de surveillance épidémiologique
- 5) Décrire les différents domaines de la surveillance épidémiologique
- 6) Citer les maladies sous surveillance épidémiologique en Côte d'Ivoire

INTRODUCTION

La surveillance épidémiologique est une fonction essentielle de la santé publique. Elle vise à fournir une image claire et actualisée de l'état de santé d'une population. C'est un outil indispensable pour protéger la santé des populations. Elle fournit des informations essentielles pour la prise de décisions éclairées et la mise en œuvre d'actions efficaces. C'est un outil d'aide à la décision pour les autorités de santé publique.

I. DEFINITION

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) : « La surveillance épidémiologique est un processus continu et systématique de collecte, d'analyse et d'interprétation de données sur la survenue et la distribution des événements de santé dans une population. »

En termes plus simples, elle est comme un système d'alerte précoce pour la santé publique, permettant de détecter rapidement les problèmes de santé et de prendre des mesures pour les contrôler.

II. OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

✓ Détection précoce des problèmes de santé :

- Identifier rapidement les épidémies, les nouvelles maladies ou les changements dans les tendances des maladies existantes.
- Détecter les menaces pour la santé publique dès leur apparition.

✓ **Suivi des tendances des maladies :**

- Surveiller l'évolution des maladies et de leurs facteurs de risque au fil du temps.
- Évaluer l'impact des interventions de santé publique.

✓ **Évaluation des interventions de santé publique :**

- Mesurer l'efficacité des programmes de prévention et de contrôle des maladies.
- Ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus.

✓ **Planification et mise en œuvre des interventions :**

- Fournir des données probantes pour la prise de décisions éclairées en matière de politiques de santé.
- Guider l'allocation des ressources et la mise en œuvre des programmes de santé.

✓ **Génération d'hypothèses de recherche :**

- Identifier les domaines nécessitant des recherches supplémentaires pour mieux comprendre les causes et les déterminants des maladies.

✓ **Diffusion de l'information :**

- Communiquer les résultats de la surveillance aux professionnels de la santé, aux décideurs et au public.
- Sensibiliser aux risques pour la santé et promouvoir les comportements sains.

III. TYPES DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

Il existe plusieurs types de surveillance épidémiologique, chacun ayant ses propres caractéristiques et objectifs. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs et peuvent être combinés pour obtenir une image plus complète de la situation épidémiologique.

Nous avons :

3.1 La surveillance passive

Elle repose sur la déclaration spontanée des cas de maladies par les professionnels de santé (médecins, infirmiers, etc.) ou par les citoyens eux-mêmes.

C'est le système le plus courant, mais il peut sous-estimer la fréquence réelle des maladies.

(Sources : **Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Surveillance**

épidémiologique et veille sanitaire et **Wikipédia : Surveillance épidémiologique**)

3.2 La surveillance active

Elle implique la recherche proactive des cas de maladies par les autorités sanitaires. Des équipes de santé se rendent sur le terrain pour collecter des données, par exemple en effectuant des enquêtes ou des tests de dépistage.

Ce type de surveillance est plus précis que la surveillance passive, mais il est aussi plus coûteux et exigeant en ressources.

(Sources : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) : Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition).

3.3 La surveillance sentinelle

Elle repose sur un réseau de professionnels de santé ou d'établissements sélectionnés pour surveiller des maladies spécifiques. Il permet de recueillir des données de qualité sur des populations ciblées, à moindre coût.

(Sources : OMS : Manuel de surveillance intégrée des maladies)

3.4 La surveillance syndromique

Elle consiste à surveiller l'apparition de groupes de symptômes (syndromes) plutôt que des maladies spécifiques. Elle permet de détecter rapidement des épidémies, avant même que les diagnostics définitifs ne soient posés.

Cette approche est particulièrement utile pour les maladies émergentes ou les menaces bioterroristes.

(Sources : CDC : Syndromic Surveillance)

3.5 La surveillance environnementale

Elle consiste à surveiller les facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine, tels que la qualité de l'eau, de l'air ou des sols. Elle permet de prévenir les maladies liées à l'environnement. (Sources : OMS : Environmental Health)

IV. PRINCIPAUX SYSTEMES DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

Les systèmes de surveillance en épidémiologie sont des outils essentiels pour suivre et analyser les données de santé publique. Ils permettent de détecter les tendances, d'identifier les épidémies et d'évaluer l'efficacité des interventions. Il est important de noter que ces systèmes peuvent être combinés et adaptés en fonction des besoins spécifiques de chaque pays ou région.

4.1 Les systèmes de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MDO)

Ces systèmes exigent que les professionnels de la santé déclarent certains cas de maladies aux autorités sanitaires. Son objectif consiste à la détection précoce des épidémies, suivi des tendances des maladies infectieuses.

Sources : Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Règlement sanitaire international (2005) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) : National Notifiable Diseases Surveillance System (NNDSS).

4.2 Les systèmes de surveillance sentinelle

Ces systèmes reposent sur un réseau de sites ou de professionnels de la santé sélectionnés pour surveiller des maladies spécifiques. Son objectif est d'obtenir des données de qualité sur des populations ciblées, de surveiller les maladies émergentes.

(Sources : OMS : Manuel de surveillance intégrée des maladies)

4.3 Les systèmes de surveillance syndromique

Ces systèmes analysent les données de symptômes pour détecter les épidémies avant que les diagnostics définitifs ne soient posés. L'objectif est de détecter rapidement les épidémies et de surveiller les menaces biologiques. **(Sources : CDC : syndrome surveillance)**

4.4 Les systèmes d'information sanitaire (SIS)

Ces systèmes collectent et analysent des données provenant de diverses sources, telles que les établissements de santé, les registres et les enquêtes. Ses objectifs sont de suivre l'état de santé de la population, de planifier et évaluer les services de santé.

(Sources : OMS : Systèmes d'information sanitaire)

4.5 Les systèmes de surveillance environnementale

Ces systèmes surveillent les facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine. Ses objectifs consistent à la prévention des maladies liées à l'environnement et à l'évaluation des risques environnementaux. **(Sources : OMS : Environmental Health)**

V. DIFFERENTS DOMAINES DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

5.1 Domaines des maladies transmissibles

- La surveillance des maladies à déclaration obligatoire
- La surveillance des épidémies
- L'investigation des épidémies
- La vaccination et surveillance des maladies évitables par la vaccination

5.2 Domaine des maladies non transmissibles

- La surveillance des maladies chroniques (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, etc.)
- La surveillance des facteurs de risque (tabagisme, obésité, etc.)
- La surveillance des traumatismes et des violences

5.3 La surveillance environnementale

- La surveillance de la qualité de l'eau et de l'air
- La surveillance des risques liés aux changements climatiques
- La surveillance des intoxications environnementales

5.4 La surveillance en santé animale

- La surveillance des zoonoses
- La surveillance des maladies animales transfrontalières
- La collaboration entre santé humaine et santé animale (approche Une seule santé) ou one Health en anglais)

VI. MALADIES SOUS SURVEILLANCE EN CÔTE D'IVOIRE

En Côte d'Ivoire, selon l'OMS, plusieurs maladies font l'objet d'une surveillance épidémiologique rigoureuse. Ce sont :

6.1 Maladies à déclaration obligatoire :

- Fièvre jaune
- Dengue
- Méningite
- Choléra
- Tétanos néonatal
- Rougeole
- Grippe
- COVID-19
- Poliomyélite
- Fièvres hémorragiques virales (Ebola, Marburg, etc.)
- Rage
- Tuberculose

6.2 Autres maladies surveillées :

- Malaria (paludisme) / Maladies diarrhéiques
- VIH/SIDA/ Hépatites B et C
- Trypanosomiose africaine (maladie du sommeil)

CONCLUSION

La surveillance épidémiologique est un investissement essentiel pour l'avenir de la santé publique. En donnant cet enseignement aux étudiants de la licence I, nous leur permettons d'avoir des capacités en matière de surveillance, pour construire des systèmes de santé plus résilients, plus équitables et plus efficaces, capables de répondre aux défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain.

COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL DE COMPORTEMENT / PLAIDOYER/ TECHNIQUE D'ANIMATION DE GROUPE

A-LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL DE COMPORTEMENT

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L2 de conduire une séance CCSC

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, l'étudiant de la licence 1 doit être capable de

- 1) Définir les termes liés au CCSC
- 2) Citer les buts du CCSC
- 3) Citer les principes de base de la CCSC
- 4) Etablir la différence entre les différents concepts utilisés en communication
- 5) Décrire les éléments constitutifs de la communication
- 6) Citer les obstacles à la communication
- 7) Citer les facteurs susceptibles d'influencer le changement social de comportement
- 8) Citer les populations cibles de la CCSC
- 9) Décrire les étapes de la conduite d'une séance de CCSC

INTRODUCTION

La communication pour le changement de comportement (CCC), désormais appelée communication pour le changement social de comportement (CCSC) est une stratégie utilisée en santé publique pour opérer un changement profond de comportement favorable à la santé chez l'individu, la famille ou la collectivité. C'est un gage de la réussite de la mission que la société nous a confiée au personnel de santé et qui consiste à assurer le bien-être de la population.

I. DEFINITIONS

1.1. Communication

C'est un processus dynamique qui permet d'assurer l'apprentissage des gestes à faire et permettre l'ancrage définitif du comportement recherché

1.2. Comportement

C'est l'ensemble des manières de faire ou de pratiques propres à un individu ou à groupe d'individus (Exemple : le refus d'adopter une méthode contraceptive).

1.3. Communication pour le Changement Social et Comportemental (CCSC)

Auparavant appelée « communication pour le changement comportemental » (CCC), la CCSC est une approche nouvelle qui favorise et facilite les changements dans les connaissances, les attitudes, les normes, les croyances et les comportements.

II. BUT DE LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL

Elle a pour but de permettre aux :

- Personnes de communiquer ou interagir avec les autres dans un cadre social ;
- Minorités d'être entendues.

III PRINCIPES DE BASE DE LA COMMUNICATION SOCIALE ET COMPORTEMENTALE

Elle se base sur :

- Les valeurs humaines et citoyennes,
- La solidarité
- Le partage.

IV.DIFFERENCE ENTRE LES CONCEPTS UTILISES EN COMMUNICATION

Concepts	Pop cible	Buts	Résultats attendus	Responsable
IEC/CCSC	Individu Communauté Société	Améliorer le bien-être de l'individu, de la communauté et de la société.	Le bien-être de l'individu, de la communauté est amélioré.	Agent de santé ONG de santé
Plaidoyer	Décideurs Politiques	Influencer le changement de politique	Le changement de politique a lieu	Agent de santé Communauté ONG
Mobilisation sociale	La société civile	Réaliser un but social commun à travers les efforts et les contributions de tous	Le but social commun à travers les efforts et les contributions de tous est réalisé	Agent de santé Communauté Société
Mobilisation communautaire	Groupe cible de la Population	Définir et exprimer ses besoins et objectifs du groupe cible, en prenant des mesures collectives visant à les satisfaire	Les besoins et objectifs du groupe cible sont définis et exprimés	ONG OBC Agent de santé

V. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMMUNICATION

5.1. L'émetteur

C'est celui qui émet le message, c'est la source.